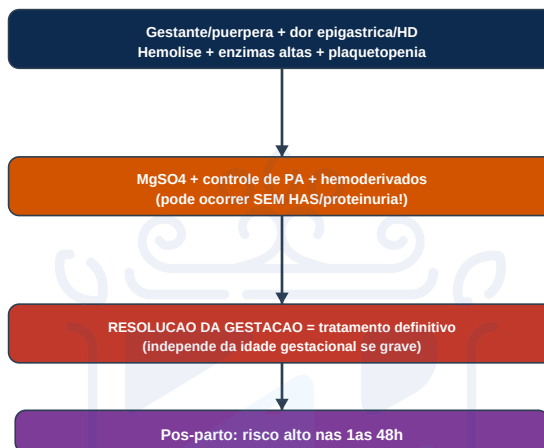


SÍNDROME HELLP — EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA

FLUXOGRAMA — RECONHECER E RESOLVER

HELLP — MgSO₄, SUPORTE E PARTO



DEFINIÇÃO E CRITÉRIOS

HEMÓLISE + ENZIMAS + PLAQUETOPENIA

- Forma GRAVE da doença hipertensiva da gestação, associada à pré-eclâmpsia
- H (Hemólise): DHL $\geq$ 600 U/L, bilirrubina indireta elevada, esquistócitos no sangue periférico
- EL (enzimas hepáticas): TGO/TGP $\geq$ 2x o normal
- LP (low platelets): plaquetas $<$ 100.000/mm³
- ATENÇÃO: pode ocorrer SEM hipertensão ou proteinúria

QUADRO CLÍNICO E COMPLICAÇÕES

QUANDO SUSPEITAR

- Dor epigástrica ou em hipocôndrio direito (distensão da cápsula hepática)
- Náuseas, vômitos, mal-estar geral; cefaleia, escotomas
- Pode evoluir para: DPP, eclâmpsia, insuficiência hepática, CIVD
- A dor epigástrica em gestante hipertensa é HELLP até prova em contrário
- Complicações graves: AVC, RUPTURA HEPÁTICA, CIVD, insuficiência renal aguda, óbito

EXAMES IMEDIATOS (sem atrasar o tratamento)

SOLICITAR

- Hemograma + PLAQUETAS SERIADAS; TGO/TGP; DHL; bilirrubinas
- Creatinina/ureia; coagulograma (TP, TTPa, FIBRINOGENIO) — avaliar CIVD
- EAS / proteinúria
- TIPAGEM sanguínea e prova cruzada (reserva de hemocomponentes)
- Avaliação da vitalidade fetal

TRATAMENTO IMEDIATO

Rx MgSO₄ + PA + HEMODERIVADOS

Sulfato de magnésio (OBRIGATÓRIO): ataque 4-6 g IV em 20 min + manutenção 1-2 g/h; manter 24h pós-parto
Monitorar: FR $\geq$ 12, reflexo patelar presente, diurese $\geq$ 25 mL/h. Antídoto: gluconato de cálcio 10% 10 mL IV
Controle da PA (meta PAS 140-150 / PAD 90-100): hidralazina, labetalol ou nifedipina (sem queda abrupta)
Plaquetas: transfundir se $<$ 20.000 (mesmo sem sangramento) OU $<$ 50.000 com sangramento/cirurgia
PFC / crioprecipitado se CIVD; concentrado de hemácias se anemia sintomática
Corticoide (se $<$ 34 sem e estável): maturação pulmonar fetal

CONDUTA OBSTÉTRICA

RESOLUÇÃO = TRATAMENTO DEFINITIVO

- Interrupção IMEDIATA (independe da idade gestacional) se: HELLP completo, instabilidade materna, sofrimento fetal, CIVD/DPP/insuficiência hepática ou renal
- Situação excepcional ($<$ 34 sem e estável): corticoide + estabilização curta (máx 24-48h) + monitorização intensiva
- Via de parto conforme condições obstétricas — NÃO pela HELLP isoladamente
- Contraindicado: conduta expectante prolongada / atrasar o parto na HELLP grave
- Evitar diuréticos (exceto EAP) e metildopa na emergência

PÓS-PARTO

VIGIAR

- ☐ Risco elevado nas primeiras 48h
- ☐ Manter sulfato de magnésio por 24h + monitorização intensiva
- ☐ As plaquetas costumam PIORAR antes de melhorar (nadir 24-48h)
- ☐ Vigiar CIVD, ruptura hepática, IRA
- ☐ Reavaliar função hepática/renal e hemograma seriados

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Gestante/puérpera, ____ semanas, com síndrome HELLP (DHL ____, TGO/TGP ____, plaquetas ____).
- Dor epigástrica/HD: sim/não; PA ____; sinais de CIVD/DPP: ____.
- Condutas: MgSO₄, anti-hipertensivo ____, hemoderivados ____, corticoide se aplicável.
- Solicito maternidade de alto risco/UTI — resolução da gestação é o tratamento definitivo.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Gestante hipertensa de 30 semanas com dor epigástrica, DHL 700, TGO 120, plaquetas 80.000. Diagnóstico e tratamento definitivo?

- A) Gastrite — inibidor de bomba e alta
- B) Síndrome HELLP — estabilizar (MgSO₄, PA, hemoderivados) e RESOLVER a gestação
- C) Colelitíase — observação
- D) Hepatite viral — antiviral
- E) Pré-eclâmpsia leve — alta com anti-hipertensivo

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quais são os critérios laboratoriais da síndrome HELLP?

- A) Leucocitose, PCR alta e febre
- B) Hemólise (DHL alto, BI elevada, esquistócitos) + enzimas hepáticas $\geq 2x$ + plaquetas < 100.000
- C) Hipoglicemia e acidose
- D) Proteinúria isolada
- E) Anemia ferropriva e plaquetose

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre a relação da HELLP com a hipertensão, é correto:

- A) Sempre cursa com PA muito elevada
- B) Pode ocorrer SEM hipertensão ou proteinúria
- C) Exclui o diagnóstico se a PA for normal
- D) Só ocorre no puerpério
- E) Nunca evolui com plaquetopenia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual o limiar de transfusão de plaquetas na HELLP SEM sangramento?

- A) < 100.000
- B) < 20.000 (mesmo sem sangramento)
- C) < 50.000 sempre
- D) Nunca transfundir
- E) < 80.000

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre as plaquetas no pós-parto da HELLP, é correto:

- A) Normalizam imediatamente após o parto
- B) Costumam PIORAR antes de melhorar (nadir nas primeiras 24-48h)
- C) Não precisam ser monitoradas
- D) Sempre exigem esplenectomia
- E) Aumentam progressivamente desde o início

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Hemólise (DHL alto) + enzimas hepáticas elevadas + plaquetopenia em gestante hipertensa com dor epigástrica = síndrome HELLP. Estabiliza-se (MgSO₄, controle da PA, hemoderivados) e o tratamento definitivo é a resolução da gestação.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Crítérios: H (hemólise — DHL $\geq$ 600, BI elevada, esquistócitos), EL (TGO/TGP $\geq$ 2x), LP (plaquetas $<$ 100.000/mm³). É forma grave da doença hipertensiva da gestação.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A HELLP pode ocorrer SEM hipertensão ou proteinúria — por isso a dor epigástrica em gestante deve sempre levantar a suspeita, mesmo com PA normal.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Transfunde-se plaquetas se $<$ 20.000 mesmo sem sangramento, ou $<$ 50.000 se houver sangramento ativo ou necessidade de cirurgia/cesárea.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

No pós-parto da HELLP, as plaquetas costumam piorar antes de melhorar (nadir 24-48h), exigindo monitorização intensiva e manutenção do MgSO₄ por 24h.

SM24
Suporte ao Plantão Médico